ONEMA-POP-056 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

Acolhimento e Primeiros Socorros em Crise Convulsiva Presenciada

por Chamada

1. Identificação institucional

2. Objetivo e abrangência

Padronizar avaliação, decisão, execução e comunicação no contexto de acolhimento e primeiros socorros em crise convulsiva presenciada por chamada, em atendimento domiciliar presencial ou remoto conforme aplicabilidade. Não substitui prescrição, avaliação médica nem instruções do fabricante.

3. Competência, indicações e contraindicações

Enfermeiro habilitado e capacitado; executar intervenções apenas no âmbito legal, da prescrição e do protocolo institucional.

Não realizar manipulação invasiva quando não houver indicação, treinamento, material adequado ou estabilidade clínica.

4. Materiais e fornecimento

Telefone/vídeo, cronômetro, contato de emergência e SAMU. Equipamentos profissionais/EPIs: enfermeiro ONEMA; consumíveis específicos: paciente/responsável, salvo ajuste contratual. Em visita presencial, equipamentos de avaliação clínica conforme indicação.

5. Avaliação e preparo

Duração, movimentos, respiração, trauma, gravidez, diabetes, epilepsia conhecida e recuperação. Confirmar identificação,

consentimento, alergias, medicamentos, ambiente, suporte disponível e condições para encaminhamento.

6. Execução técnica numerada

01. Confirmar endereço exato, início da crise e presença de acompanhante.

02. Orientar proteção da cabeça e afastamento de objetos perigosos; não restringir movimentos.

03. Não colocar objetos na boca nem oferecer água ou medicamentos por via oral durante crise.

04. Cronometrar; se durar cinco minutos ou mais, crises repetidas sem recuperação, primeira crise ou trauma importante,

acionar SAMU 192.

05. Após movimentos cessarem, verificar respiração e orientar posição lateral de segurança se respirar normalmente.

06. Se não respirar normalmente, orientar RCP e seguir regulador do SAMU.

07. Manter observação até recuperação, sem presumir diagnóstico de epilepsia.

08. Registrar cronologia, sinais, medidas e destino.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Crise prolongada, recorrente, gravidez, lesão, dificuldade respiratória ou recuperação incompleta: emergência. Na emergência, acionar SAMU 192 e registrar o horário. Não insistir em procedimento inseguro.

8. Cuidados posteriores e orientações

Orientar avaliação médica e medidas de prevenção de acidentes até esclarecimento.

9. Carteira Digital ONEMA

Registrar data/hora, modalidade, identificação e consentimento, achados positivos e negativos, sinais vitais se pertinentes,

intervenção passo a passo, materiais/dispositivo quando aplicável, intercorrências, comunicação, encaminhamento, orientações, plano de seguimento e identificação profissional.

10. Referências técnicas rastreáveis

CDC Seizure First Aid; NICE NG217 Epilepsies in children young people and adults | Conferir aplicação integral ao cenário brasileiro e IFU específico antes de liberação assistencial.

aplicativo.